

PREGUNTAS DEL TRIBUNAL -- CON RESPUESTAS MODELO

TFM: "Como afectan la autoestima y el autoconcepto al bienestar. Una revision paraguas de meta-analisis en psicologia clinica y de la salud (2016-2026)"

****INSTRUCCION****: Las preguntas estan ordenadas de mas probables a mas tecnicas. Lee cada respuesta y adaptala a tu propio lenguaje. No las memorices: entiendelas. El tribunal valora que razones, no que recitas.

BLOQUE I -- CONCEPTOS TEORICOS Y JUSTIFICACION

P1. ¿Por que distingues entre autoestima y autoconcepto si en muchos estudios se usan como sinonimos?

Respuesta: Precisamente por eso es relevante la distincion. La **falacia jingle** consiste en usar el mismo nombre para dos constructos distintos, y la **falacia jangle** en lo contrario. Historicamente, autoestima y autoconcepto se han usado indistintamente, pero son conceptualmente diferentes: la autoestima es esencialmente **evaluativa y global** --cuanto me valoro-- mientras que el autoconcepto es **descriptivo y multidimensional** --como me veo en distintos dominios: academico, social, fisico, emocional. Shavelson y Marsh demostraron que el autoconcepto tiene una estructura jerarquica. En la practica clinica esto importa: una persona puede tener autoestima global baja pero un autoconcepto fisico positivo, o viceversa. Si los tratamos como sinonimos, perdemos precision diagnostica e intervenimos de forma menos especifica.

P2. ¿Que aportacion novedosa tiene tu trabajo respecto a Zell y Johansson (2025)?

Respuesta: Zell y Johansson (2025) es la revision mas reciente y amplia sobre autoestima y bienestar, con una correlacion global de $r = .31$. Sin embargo, tiene una limitacion clave: mezcla poblaciones clinicas y no clinicas. Mi trabajo **restringe el foco a poblaciones clinicas** ($\geq 75\%$ de cada meta-analisis), lo que permite responder a una pregunta mas especifica y clinicamente relevante: ¿tiene el mismo efecto la autoestima en quien tiene un diagnostico que en quien no lo tiene? Los datos sugieren que si, y que el efecto es **mayor en contextos clinicos**, especialmente en salud mental. Ademias, yo integro tanto autoestima como autoconcepto, mientras que Zell y Johansson se centran casi exclusivamente en autoestima global.

P3. ¿Por que elegiste el periodo 2016-2026 y no uno mas amplio?

Respuesta: El criterio fue tanto practico como metodologico. Desde 2016, el campo experimento un auge significativo de meta-analisis sobre autoestima y bienestar en poblaciones clinicas, especialmente vinculado a la adopcion de estandares de reporte como PRISMA. Retroceder mas en el tiempo habria incorporado meta-analisis con menor rigor metodologico y posiblemente con instrumentos de medida ya obsoletos. Ademas, la revision paraguas mas comprehensiva previa a mi trabajo --el meta-analisis de Mann et al.-- cubre hasta aproximadamente 2014, por lo que la ventana 2016-2026 actualiza el estado de la evidencia de forma complementaria.

P4. ¿Que es exactamente una revision paraguas y en que se diferencia de un meta-analisis o una revision sistematica?

Respuesta: Una **revision sistematica** sintetiza estudios primarios (ensayos clinicos, estudios observacionales...) sobre una pregunta concreta. Un **meta-analisis** va un paso mas alla: combina estadisticamente los resultados de esos estudios primarios para obtener un tamano del efecto global. Una **revision paraguas** (*umbrella review*) esta un nivel por encima: sintetiza meta-analisis ya existentes. Su objetivo es dar una vision panoramica de un campo cuando hay muchos meta-analisis con preguntas parcialmente solapadas. La analogia del paraguas es apropiada: abarca todo lo que hay debajo. La ventaja es la cobertura; la limitacion, que dependemos de la calidad de los meta-analisis incluidos y no podemos acceder directamente a los estudios primarios.

BLOQUE II -- METODOLOGIA

P5. ¿Por que una unica revisora? ¿No es eso una limitacion critica?

Respuesta: Si, y lo reconozco explicitamente como la principal limitacion del trabajo. El estandar metodologico en revisiones sistematicas exige al menos dos revisores independientes en las fases de cribado y seleccion, con calculo del acuerdo inter-jueces mediante el indice kappa de Cohen. Que el trabajo lo haya realizado una unica revisora incrementa el riesgo de sesgo de seleccion. Sin embargo, hay que contextualizarlo: se trata de un TFM, con limitaciones de tiempo y recursos inherentes a su naturaleza academica. Para mitigar este riesgo, aplique criterios de inclusion/exclusion exhaustivos y explicitos, documente todas las decisiones, y consulte con la tutora en los casos dudosos. En una version de investigacion real, seria la primera mejora a implementar.

P6. Explicame el CCA de 1,4%. ¿Que significa exactamente y por que es importante?

Respuesta: El **Indice de Solapamiento Corregido (CCA, por sus siglas en ingles: Corrected Covered Area)** mide el porcentaje de estudios primarios que se repiten entre los meta-analisis incluidos en la revision paraguas. Se calcula como: el numero de pares de estudios solapados dividido por el total posible de pares. Un CCA **inferior al 5%** indica solapamiento leve, lo que valida la independencia de los meta-analisis entre si. En mi corpus, el CCA fue del **1,4%**, lo que es muy bajo y confirma que los 13 meta-analisis estan trabajando sobre muestras de estudios primarios mayoritariamente distintas. Esto es importante porque si el CCA fuera alto, las conclusiones de distintos meta-analisis estarian basadas en los mismos datos, y la agregacion seria redundante e inflaria artificialmente la confianza en los resultados.

P7. ¿Que es AMSTAR-2 y como lo aplicaste?

Respuesta: **AMSTAR-2** (*A MeaSurement Tool to Assess systematic Reviews*, version 2) es el instrumento de referencia para evaluar la calidad metodologica de revisiones sistematicas y meta-analisis. Consta de **16 items**, de los cuales **7 son criticos**: entre ellos, si el protocolo fue prerregistrado, si la busqueda fue exhaustiva, si se evaluo el riesgo de sesgo de los estudios primarios, y si se tuvo en cuenta ese riesgo al interpretar los resultados. Cada item se puntua como Si / Si parcial / No. La calidad global es: Alta (ningun item critico fallando), Moderada (un item critico fallando), Baja (mas de un item critico fallando) y Criticamente baja (multiples items criticos fallando). Lo aplique de forma sistematica a los 13 meta-analisis del corpus, documentando cada item en el Anexo A.2.

P8. ¿Que es el marco PECO y por que usaste ese y no PICOS?

Respuesta: El marco **PECO** --Poblacion, Exposicion, Comparacion, Outcome-- es mas adecuado para preguntas de **investigacion observacional** sobre factores de riesgo o predictores, que es precisamente mi pregunta: ¿como se asocia la autoestima/autoconcepto (exposicion) con el bienestar (outcome) en poblaciones clinicas? El marco **PICOS** incorpora la *I* de Intervencion, lo que lo hace mas apropiado para preguntas sobre eficacia de tratamientos (ensayos clinicos). Como mi trabajo no estudia intervenciones sino asociaciones, PECO era el marco adecuado. La eleccion del marco no es cosmetica: define los criterios de inclusion y la estrategia de busqueda.

P9. ¿Como construiste la estrategia de busqueda? ¿Puedes explicarla?

Respuesta: La estrategia se estructuro en **tres bloques semanticos** conectados por el operador booleano AND:

- **Bloque 1** (predictor): terminos relacionados con autoestima y autoconcepto: *self-esteem, self-concept, self-worth, self-image, RSES, SDQ, Rosenberg, Shavelson...* conectados con OR.
- **Bloque 2** (outcome): terminos de bienestar: *wellbeing, well-being, quality of life, mental health, HRQoL, life satisfaction, psychological well-being...* conectados con OR.
- **Bloque 3** (diseno): terminos metodologicos: *meta-analysis, systematic review, umbrella review, meta-analytic...* conectados con OR.

Los tres bloques se conectaron entre si con AND, de modo que solo se recuperaban articulos que mencionaran los tres componentes. La estrategia completa, adaptada a cada base de datos, esta en el Anexo A.1 del trabajo.

BLOQUE III -- RESULTADOS

P10. Los resultados de calidad son muy malos: solo 1 meta-analisis con calidad Alta. ¿No invalida eso tus conclusiones?

Respuesta: Es una pregunta importante y legitima. No invalida las conclusiones, pero si las condiciona. La calidad metodologica baja de los meta-analisis significa que los tamanos del efecto reportados podrian

estar sobreestimados debido a sesgos de seleccion, heterogeneidad sin explicar, o falta de evaluacion del riesgo de sesgo de los estudios primarios. Por eso, en la discusion, enfatizo que las conclusiones deben leerse con **cautela** y distinguiendo entre el meta-analisis de calidad Alta --el de suicidalidad-- cuyas conclusiones son mas solidas, y el resto. Que el campo tenga calidad metodologica baja no es un hallazgo menor: es en si mismo un resultado relevante que senala la necesidad de estandares mas rigurosos. Y, paradójicamente, es una aportacion adicional de este trabajo: mapear el estado metodologico del campo.

P11. ¿Que significa exactamente el efecto indirecto $\beta = -.189$ del MASEM del Bloque E?

Respuesta: El **MASEM** (*Meta-Analytic Structural Equation Modelling*) es una tecnica que permite ajustar un modelo de ecuaciones estructurales utilizando como datos de entrada las matrices de correlacion de multiples meta-analisis. En el Bloque E, el modelo examina si el autoconcepto **media** la relacion entre gravedad clinica (síntomas, diagnostico) y bienestar. El efecto indirecto de $\beta = -.189$ significa que parte del impacto de la enfermedad sobre el bienestar se produce **a traves del deterioro del autoconcepto**. Traducido a lenguaje clinico: la enfermedad reduce el bienestar en parte porque deteriora la imagen que el paciente tiene de si mismo. Ese es el mecanismo. Es un efecto pequeno-moderado, pero estadísticamente significativo y teóricamente relevante, porque senala el autoconcepto como un **mecanismo de accion modificable** en intervencion.

P12. ¿Por que los efectos del Bloque D (afirmacion de genero) son tan grandes (g hasta $-.99$)?

Respuesta: Los efectos grandes en poblacion transgenero y no binaria sometida a tratamiento de afirmacion de genero se pueden interpretar desde varias perspectivas. Por un lado, tiene sentido clinico: la disforia de genero produce un desajuste severo entre autoconcepto corporal e identidad, y el tratamiento de afirmacion resuelve precisamente ese desajuste, por lo que la mejora en autoconcepto corporal y bienestar puede ser muy pronunciada. Por otro lado, hay razones metodologicas para ser cauto: los meta-analisis de este bloque tienen **calidad Baja en AMSTAR-2**, lo que implica riesgo de sesgo de publicacion (los estudios con efectos grandes se publican mas) y heterogeneidad sin explicar. Por eso, aunque el efecto es sugerente y clinicamente relevante, requiere replicacion con estudios metodologicamente mas solidos.

P13. ¿Por que el resultado de suicidalidad (Bloque A) merece mas confianza que el resto?

Respuesta: Por dos razones convergentes. Primero, es el unico meta-analisis del corpus con **calidad Alta en AMSTAR-2**, lo que significa que tiene preregistro, busqueda exhaustiva, evaluacion del riesgo de sesgo de los estudios primarios, y que esa evaluacion se tuvo en cuenta en la sintesis. Segundo, es el meta-analisis mas grande del corpus: **k=114 estudios**, lo que proporciona una estimacion mas estable del tamano del efecto. La correlacion negativa entre autoestima y suicidalidad de r entre $-.26$ y $-.44$ es robusta, consistente y clinicamente significativa: un tamano de efecto moderado-grande que justifica la incorporacion de la medida de autoestima en protocolos de evaluacion del riesgo suicida.

BLOQUE IV -- IMPLICACIONES CLINICAS Y LIMITACIONES

P14. Como psicologa sanitaria, ¿como aplicarias los resultados de tu TFM en la practica clinica?

Respuesta: En mi practica, incorporaria tres cambios concretos:

Primero, evaluacion: En la evaluacion inicial de cualquier paciente con trastorno del estado de animo, trastorno de ansiedad, o en contextos de riesgo suicida, incluiria sistematicamente la **Escala de Rosenberg (RSES)** y, en casos con problematica de imagen corporal o identidad, el **SDQ (Self-Description Questionnaire)**. Son instrumentos breves, de libre acceso, con buenas propiedades psicometricas, y los resultados de este trabajo muestran que son predictores relevantes del bienestar y del riesgo.

Segundo, intervencion: Para pacientes con baja autoestima como problema principal o secundario, contemplaria protocolos especificos como el **COMET (Competitive Memory Training)**, disenado especificamente para la autoestima, o la **terapia cognitiva de Fennell**, que trabaja los esquemas de autoconcepto negativo. Los resultados del Bloque E sugieren que trabajar el autoconcepto como mecanismo mediador puede tener efectos sobre el bienestar general, no solo sobre la autoestima.

Tercero, prevencion: En servicios de salud mental con funcion de cribado, recomendaria incluir la RSES como indicador de alarma en protocolos de prevencion suicida, especialmente en adolescentes y adultos jovenes.

P15. ¿Por que no incluiste estudios sobre intervenciones? ¿No habria sido mas util clinicamente?

Respuesta: Es una decision metodologica deliberada, no una limitacion accidental. Las revisiones sobre **asociaciones** y las revisiones sobre **eficacia de intervenciones** responden a preguntas distintas con disenos distintos. Mi pregunta era: ¿se asocian autoestima y autoconcepto con el bienestar en poblaciones clinicas, y en que medida? Para eso, los estudios observacionales y correlacionales son el diseno adecuado. Los RCT responden a una pregunta diferente: ¿funciona esta intervencion? Mezclar ambos tipos habria comprometido la coherencia metodologica de la sintesis. Sin embargo, abro explicitamente en las lineas futuras la necesidad de realizar una revision paraguas sobre **intervenciones** sobre autoestima/autoconcepto en poblaciones clinicas, que seria el complemento natural a este trabajo.

P16. ¿Como definiste operacionalmente el criterio del 75% de poblacion clinica?

Respuesta: El criterio del **≥75% de poblacion clinica** se aplico revisando los criterios de inclusion de cada meta-analisis: si el meta-analisis solo incluia estudios con muestras clinicas, o si explicitamente requeria diagnostico, cumplia el criterio. Cuando el meta-analisis mezclaba poblaciones, revise si la proporcion de estudios con poblacion clinica superaba el 75% del total de estudios primarios incluidos. Este umbral es convencional en la literatura de revisiones paraguas y garantiza que las conclusiones se puedan generalizar a contextos clinicos, no a poblacion general. Los meta-analisis que no cumplieran este criterio fueron excluidos en la fase de elegibilidad.

BLOQUE V -- PREGUNTAS MAS TECNICAS / AVANZADAS

P17. ¿Que diferencia hay entre d^ de Cohen, g^* de Hedges y r^* de Pearson como tamanos del efecto, y por que aparecen distintos en tu corpus?*

Respuesta: Los tres son metricas de tamano del efecto, pero se usan en contextos distintos:

- **r de Pearson:** mide la correlacion entre dos variables continuas. Va de -1 a $+1$. Convencionalmente: pequeno (0.1), mediano (0.3), grande (0.5). Aparece en los estudios de asociacion (Bloques A y B).
- **d de Cohen:** diferencia entre medias estandarizada. Se usa cuando se comparan dos grupos (ej. obesos vs. controles). Convencionalmente: pequeno (0.2), mediano (0.5), grande (0.8).
- **g de Hedges:** igual que d , pero con correccion para muestras pequenas. Es preferible cuando los grupos tienen tamanos muy distintos o las muestras son pequenas.

Aparecen distintos en mi corpus porque los meta-analisis incluidos usaban disenos distintos: algunos eran correlacionales ($\rightarrow r$), otros comparaban grupos ($\rightarrow d$ o g). En la sintesis no los converti entre si artificialmente; organice los resultados por bloques tematicos que internamente son metodologicamente homogeneos.

P18. ¿Que es PRISMA 2020 y en que se diferencia de versiones anteriores?

Respuesta: **PRISMA** (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*) es una guia de reporte que establece que informacion debe incluir una revision sistematica o meta-analisis para ser transparente y replicable. La version 2020 actualizo la del 2009 en varios puntos clave: incorpora la evaluacion de la certeza de la evidencia con GRADE, incluye un item especifico para el prerregistro, exige reportar el solapamiento entre estudios en revisiones paraguas (el CCA), y amplia las instrucciones para busquedas en literatura gris. En mi trabajo segui PRISMA 2020, que es el estandar actual, junto con **PRIOR** (*Preferred Reporting Items for Overviews of Reviews*), que es la extension especifica de PRISMA para revisiones paraguas.

P19. ¿Podrias haber hecho un meta-analisis cuantitativo global en lugar de una sintesis narrativa por bloques?

Respuesta: Tecnicamente, si. Pero no hubiera sido metodologicamente apropiado. Para combinar estadisticamente los tamanos del efecto de distintos meta-analisis, se requiere que sean **suficientemente homogeneos** en terminos de poblacion, predictor, outcome y disenio. En mi corpus, los 13 meta-analisis son muy heterogeneos: comparan distintas poblaciones (obesidad pediatrica, suicidalidad, afirmacion de genero...), usan distintas metricas de tamano del efecto (r , d , g), y miden distintas dimensiones del bienestar. Una sintesis cuantitativa global habria producido un numero sin sentido interpretativo, como hacer la media entre manzanas y naranjas. La sintesis por bloques tematicos homogeneos es metodologicamente mas honesta y produce conclusiones mas interpretables.

P20. ¿Cual es la diferencia entre el sesgo de publicacion y el riesgo de sesgo de los estudios primarios? ¿Los evaluaste?

Respuesta: Son dos niveles distintos de sesgo:

El **riesgo de sesgo de los estudios primarios** se refiere a problemas en el diseño de los estudios individuales: falta de aleatorización, pérdidas de seguimiento, medidas no cegadas... Se evalúa con herramientas como ROB-2 (para RCTs) o ROBINS-I (para estudios observacionales). En el contexto de AMSTAR-2, evalúe si los propios meta-análisis habían evaluado el riesgo de sesgo de sus estudios primarios (ítem 9 de AMSTAR-2), y si habían tenido en cuenta esa evaluación en sus conclusiones (ítem 13). La mayoría no lo habían hecho adecuadamente, lo que contribuyó a las calificaciones bajas.

El **sesgo de publicación** (*publication bias*) es el fenómeno por el cual los estudios con resultados positivos o significativos se publican más que los nulos o negativos. En revisiones paraguas no puedo calcularlo directamente (al estar un nivel por encima), pero sí verifique si los meta-análisis del corpus habían evaluado el sesgo de publicación con funnel plots o tests de Egger. Los de calidad baja frecuentemente no lo habían hecho.

P21. Si pudieras repetir el trabajo, ¿que cambiarías?

Respuesta: Cambiaría tres cosas fundamentales:

Primero, dos revisores independientes desde el inicio, con cálculo del kappa de Cohen en la fase de selección.

Segundo, preregistraría el protocolo en PROSPERO antes de iniciar la búsqueda, lo que aumenta la transparencia y reduce el riesgo de hipótesis post-hoc.

Tercero, incluiría una evaluación de la certeza de la evidencia con GRADE (*Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation*), que permite ir más allá de la calidad metodológica del meta-análisis y valorar la solidez global de la evidencia para cada conclusión. Esto hubiera permitido dar recomendaciones clínicas con un nivel de certeza explícito (alta, moderada, baja, muy baja).

BLOQUE VI -- PREGUNTAS DE "TRAMPA" O DIFÍCILES

P22. ¿Como puedes afirmar que la autoestima afecta al bienestar si tus estudios son correlacionales? Poria ser al revés.

Respuesta: Es una crítica completamente válida y es la limitación fundamental de los estudios correlacionales: **no permiten establecer causalidad**. Tienen razón: una persona con peor bienestar puede desarrollar menor autoestima, y no necesariamente al revés. La mayoría de los meta-análisis del corpus son transversales o correlacionales. No puedo afirmar con mis datos que la autoestima *causa* el bienestar. Lo que sí puedo afirmar es que ambas variables están consistentemente asociadas, con un patrón de dirección coherente con la teoría, y que en el Bloque E el modelo de mediación sugiere un mecanismo plausible. Para establecer causalidad se necesitarían estudios longitudinales con medidas repetidas, que es una de las líneas futuras que planteo explícitamente.

P23. ¿Por que el bienestar eudaimonico aparece tan poco en tu corpus comparado con el hedonico?

Respuesta: Es un hallazgo indirecto interesante. La literatura clinica ha operacionalizado el bienestar predominantemente con medidas de calidad de vida relacionada con la salud (HRQoL) y sintomas psicopatologicos (que se aproximan al polo hedonico/ausencia de malestar), mientras que el bienestar eudaimonico --proposito, crecimiento personal, autonomia-- ha recibido menos atencion en contextos clinicos. Esto puede deberse a que los instrumentos eudaimonicos (como las Escalas de Bienestar Psicologico de Ryff) son menos conocidos en contextos medicos y clinicos, o a que el foco de la psicologia clinica ha sido historicamente la reduccion del malestar mas que la promocion del florecimiento. Senalo esto en la discusion como una laguna del campo.

P24. ¿Cual es la relevancia de tu TFM para la practica del psicologo sanitario especificamente, y no del psicologo clinico general?

Respuesta: Es una distincion importante. El **psicologo sanitario** en Espana trabaja en contextos de salud con una orientacion mas preventiva y de atencion primaria que el psicologo clinico especialista. Los resultados de este trabajo son especialmente relevantes para el psicologo sanitario en tres sentidos:

Primero, cribado: La RSES puede incorporarse facilmente en protocolos de cribado en atencion primaria, consultas de pediatria, unidades de salud reproductiva o servicios de oncologia, todos ellos contextos donde el psicologo sanitario tiene presencia.

Segundo, prevencion: Los efectos en obesidad pediatrica y salud reproductiva (PCOS) son especialmente relevantes para intervenciones preventivas en etapas tempranas, antes de que el deterioro del autoconcepto cronifique.

Tercero, orientacion biopsicosocial: El psicologo sanitario trabaja en la interseccion entre salud fisica y salud mental. Los Bloques B y C (salud somatica) muestran que el autoconcepto predice bienestar incluso en condiciones medicas "fisicas" como la obesidad o el PCOS, lo que refuerza el modelo biopsicosocial y la pertinencia de la psicologia en esos contextos.

[FIN DEL DOCUMENTO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS]